就医后的回访，都是很好的宣传时机。从定点医院，综合医院再到社区医院，都可以对来就诊的患者提供相关防治知识，在一项由专业医生护士组成团队对就诊患者进行健康宣教的研究中，该团队针对不同居民的需求提供相应的知识，定期推送视频讲解，与居民进行互动答疑，不断优化健康教育方式，使居民得到全程有效的宣教，使居民的结核相关知识知晓率大大提升，有医务人员指导的健康支持教育其他方式具有专业性，可靠性，且借助社交软件，互动性强，能帮助患者更好的获取知识。

5、小结

尽管我国在“十三五”规划中提出结核病防治核心知识知晓率需达 85%以上，但多项调查显示，不同地区、人群的知晓率仍存在显著差异，且未完全达标，尤其是大学生、老年人、流动人口及少数民族等群体的知晓率亟待提升。结核防治核心知识的普及受文化程度、民族、年龄等多因素影响，其中文化程度低、信息获取途径有限及宣教方式针对性不足是关键制约，提高公众对结核病防治知识的知晓率是降低发病率和复发率的重要手段。对于防控策略的优化方向：传统书面与口语宣教需与 5G 网络、数智化平台等现代技术结合，提升信息传播效率；同时强化医护人员的专业宣教作用，针对特殊人群制定分层干预方案，强化对不同医疗机构的医务人员进行结核防治知识规范的培训及管理。未来需通过多元化、精准化的健康教育策略，多维度、多方面的开展宣传方式，鼓励动员全社会共同参与，组建扩大知识传播的志愿者队伍，提升全民结核病防治核心知识水平及健康素养，助力实现“终止结核病流行”的全球目标。

参考文献（略）

藏区结核病患者异地就医旅程地图的研究

张淼

（成都市公共卫生临床医疗中心，四川成都，610066）

通信地址：成都市锦江区静明路 377 号

邮政编码：610066

摘要：目的：探讨藏区结核病患者在异地就医过程中所面临的挑战与痛点，并基于患者旅程地图方法，分析其就医体验，提出优化方案，以提升患者的就医体验和医疗服务质量。**方法：**本研究采用调查员陪同患者就诊的方式，选取了 8 名藏族结核病患者，涵盖了门诊和住院科室的各个就诊环节。通过观察和记录患者在挂号、候诊、就诊、检查、取药等环节中的情绪波动、行为反应及需求变化，系统识别患者的痛点并绘制患者旅程地图，量化分析就医过程中的关键问题。**结果：**研究发现，藏族结核病患者在就医过程中存在显著的痛点，主要包括挂号与缴费流程复杂、候诊环境差、标识指引不清晰、就医流程不明确、语言沟通障碍及文化适配性不足等问题。患者在门诊和住院过程中均表现出焦虑和不便，尤其是在 CT 检查等待时间过长、语言障碍和饮食习惯不适应等方面存在较大困难。**结论：**本研究通过旅程地图法深入分析了藏区结核病患者的就医体验，提出了优化建议，如增加藏汉双语标识、改善就医环境、简化就诊流程、加强文化适配性等措施。研究结果为改善藏族结核病患者的就医体验提供了实证依据，能够有效减少患者的就医障碍，提升医疗服务的质量，推动智慧医院建设的发展。

中国知网 https://www.cnki.net